HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ

Конспект урока — Изжога, рефлюкс, ГЭРБ. Часть 2

1. Две стратегии работы с изжогой и ГЭРБ

В первой части мы разбирали, **откуда берётся изжога** и какие механизмы её поддерживают. Этот урок — о том, что с ней **делать**: как вывести ГЭРБ в ремиссию и не допустить дальнейшего развития болезни.

1. Быстрое уменьшение симптомов — снять жжение и боль здесь и сейчас.

2. Устранение причин, поддерживающих рефлюкс — работа с механизмом, из-за которого заброс вообще происходит.

Важно: первая стратегия работает ровно до тех пор, пока вы принимаете средство. Вторая — даёт стойкий результат.

Идеально, когда обе стратегии применяются одновременно.

2. Ингибиторы протонной помпы (ИПП)

Омепразол, Пантопразол, Эзомепразол и другие препараты с окончанием «-празол».

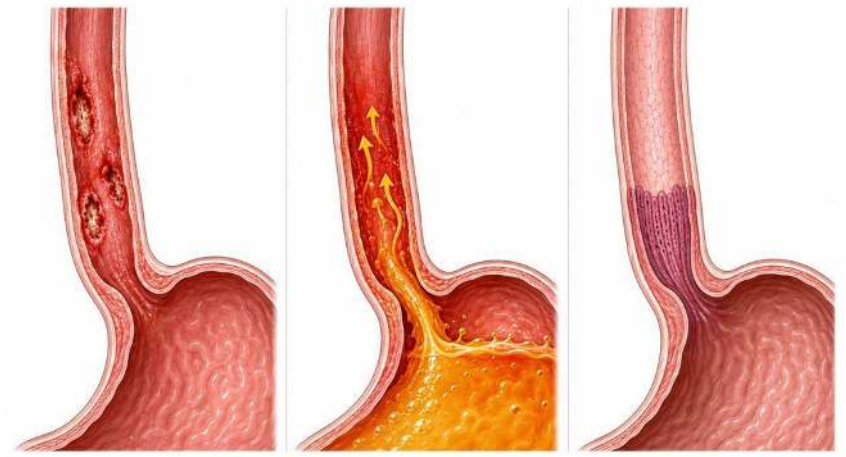
Как работают? **Уменьшают образование соляной кислоты в желудке.**
Мгновенного эффекта нет: уже начавшийся приступ изжоги они не снимут. Эффект накопительный и наиболее выражен через несколько дней регулярного приёма — рефлюкс становится менее кислым и меньше повреждает пищевод.



Когда они действительно нужны

ИПП — препараты первой линии при:

- эрозивном эзофагите;
- язвах пищевода;
- тяжёлой форме ГЭРБ;
- пищеводе Барретта.



Эрозии, активное воспаление и пищевод Барретта — ситуации, где ИПП обоснованы

Чего ИПП не делают

ИПП не устраняют причину рефлюкса. Если сохраняются ожирение, переедание, слабость нижнего пищеводного сфинктера, нарушение моторики, высокое внутрибрюшное давление — после прекращения приёма **симптомы ГЭРБ вернутся.** Это заплатка, а не решение.

ИПП назначает врач — после обследования и при наличии показаний. Принимать их «как конфетки», продлевая курс самостоятельно, нельзя.

3. Риски длительного приёма ИПП

1. Снижение функции желудка.

Падает выработка соляной кислоты → хуже активируются пищеварительные ферменты → пища хуже переваривается. Из неё хуже высвобождаются и усваиваются **белок, витамин B_{12}, железо, кальций и магний.**

2. Повышение риска инфекций желудка и кишечника.

Среда в желудке защелачивается, и **Helicobacter pylori** — которая любит щелочную среду — начинает активно колонизировать желудок, выходя за пределы пилорического отдела. Растёт и риск **Clostridioides difficile** в кишечнике. *Поэтому*

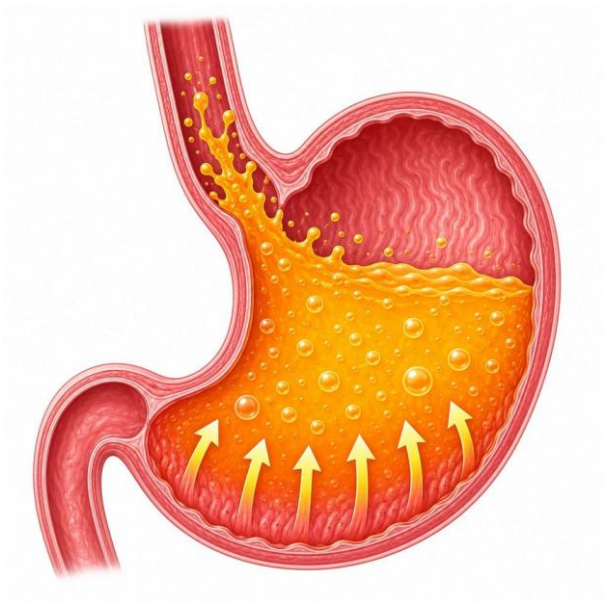
перед планируемым длительным курсом обычно проводят обследование на H. pylori.

3. Синдром «кислотного рикошета» после резкой отмены.

Длительный приём ИПП должен проходить под наблюдением врача и только при наличии показаний.

4. Почему нельзя резко отменять ИПП

После длительного приёма может развиваться **синдром кислотного рикошета.** Желудок временно начинает вырабатывать **больше кислоты, чем до лечения** — и симптомы ГЭРБ усиливаются.



Почему это важно: именно из-за рикошета людям так трудно «слезть» с ИПП. Изжога возвращается сильнее прежней, человек снова начинает пить препарат — и круг замыкается.

От ИПП отказываются постепенно. Грамотный врач расписывает схему отмены со снижением дозировки и введением альтернативных препаратов.

5. Антациды

Маалокс, Алмагель, Фосфалюгель.

Нейтрализуют **уже выделившуюся** соляную кислоту и уменьшают жжение.

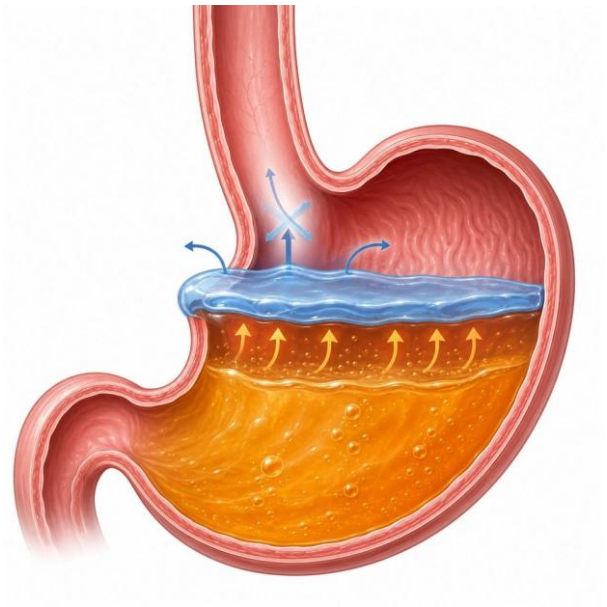


Вариант симптоматической помощи: действуют быстро, но недолго. *Не предотвращают новые эпизоды рефлюкса и не устраняют причину заболевания.*

6. Альгинаты

Гевискон и другие препараты на основе альгината натрия.

После попадания в желудок образуют **защитный гель («плавающий плот»)**, который располагается поверх желудочного содержимого и уменьшает попадание кислоты в пищевод.



«Плавающий плот» альгината перекрывает выход кислоты в пищевод

Действуют быстро, практически не влияют на кислотность желудка, подходят для симптоматического облегчения.

7. Прокинетики и гастропротекторы

Итоприд, Домперидон.

Их задача — ускорить эвакуацию пищи из желудка и уменьшить вероятность рефлюкса.

Зачем они нужны: приём ИПП сам по себе замедляет опорожнение желудка — выделение кислоты влияет на его моторику. Прокинетики нивелируют этот эффект. Кроме того, они помогают **мягко и без «кислотного рикошета» отказаться от ИПП.**

Дополнительно используются гастропротекторы

Растительные средства со слизистыми полисахаридами: **корень алтея, скользкий вяз, деглицирризированная солодка (DGL).** Слизистые вещества временно покрывают слизистую защитным слоем и уменьшают раздражение.

Подробности — в уроке «Заживляем слизистую»: там есть важные нюансы применения. Все лекарственные препараты и схемы их отмены назначает врач.

8. Сода при изжоге — почему так делать не стоит

Самый известный «народный» рецепт: началась изжога — выпить соду. Сода действительно **на несколько минут** уменьшает изжогу, потому что щёлочь гасит кислоту. **Но эффект очень кратковременный — 20–30 минут.**



Что происходит дальше:

- **Желудок компенсирует защелачивание** — он эволюционно устроен так, чтобы поддерживать стабильную кислотность, и в ответ начинает вырабатывать кислоты **больше, чем было.**
- **Образуется углекислый газ.** При гашении кислоты щёлочью выделяется CO_2 — тот самый «гейзер», который легко воспроизвести дома с лимонной кислотой.
- **Желудок растягивается**, внутрижелудочное давление растёт, газ ищет выход — и находит его в пищеводе, увлекая за собой содержимое желудка.

При частом использовании соды можно поймать кислотный рикошет — как при отмене ИПП. Сода не рекомендуется как способ лечения ГЭРБ.

9. База коррекции ГЭРБ — образ жизни

Это то, что нужно делать **всем**, независимо от типа изжоги и механизма её формирования.

- **Поддерживать нормальную массу тела** — особенно убирать висцеральный жир на животе.
- **Отказаться от курения.**
- **Ограничить употребление алкоголя.**
- **Не носить тесную одежду**, тугие ремни, пояса и корсеты — они повышают внутрибрюшное давление.
- **Пересмотреть препараты**, которые могут усиливать рефлюкс — *совместно с врачом, ничего не отменяя резко.*

Про вес: это одна из самых доказанных мер. Исследования показывают, что снижение массы тела **даже на 5–10%** у людей с избыточным весом значимо уменьшает изжогу, отрыжку и регургитацию. Висцеральный жир буквально сдавливает желудок и повышает внутрибрюшное давление — убирая его, мы убираем одну из ключевых причин.

Про одежду: *растягивайте пояс, когда сидите за столом или в транспорте; покупайте вещи с широкими, не обтягивающими поясами. Особенно важно в период активного лечения.*

10. Сон

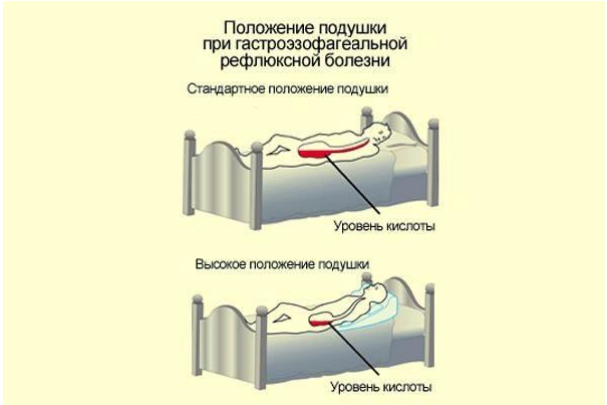
Ночной рефлюкс — один из самых повреждающих факторов для слизистой пищевода. Когда мы лежим, кислота задерживается в пищеводе надолго.

Что делать:

- **Соблюдать режим сна.** Лучший друг смыкания нижнего пищеводного сфинктера — гормон сна **мелатонин**; он же помогает восстанавливать слизистую и снижать воспаление.
- **Ловить пик мелатонина** — примерно с 22:00 до 2–3 часов ночи.
- **Не ложиться после еды** — минимум 2 часа.
- **Ужинать за 3–4 часа до сна.** *Поздние плотные ужины — один из самых частых провокаторов ночной изжоги.*
- **По возможности спать на левом боку.**
- **Спать с приподнятым головным концом кровати** на 10–15 см.
- **Обеспечить прохладную, тёмную и хорошо проветриваемую спальню.**



На левом боку желудок оказывается ниже пищевода — забросы затрудняются



Стандартное и приподнятое положение головного конца: уровень кислоты

Бережём сон — бережём мелатонин. Это одновременно работа со сфинктером, с воспалением и со стрессом.

11. Физическая активность

Нагрузка полезна, но не любая: всё, что повышает внутрибрюшное давление, усиливает рефлюкс.

Ограничить:

- ✔ вакуум живота
- ✔ поднятие тяжестей
- ✔ упражнения с сильным напряжением пресса
- ✔ глубокие наклоны сразу после еды
- ✔ интенсивные силовые тренировки

→ после плотной еды — минимум час до нагрузки.

Полезны:

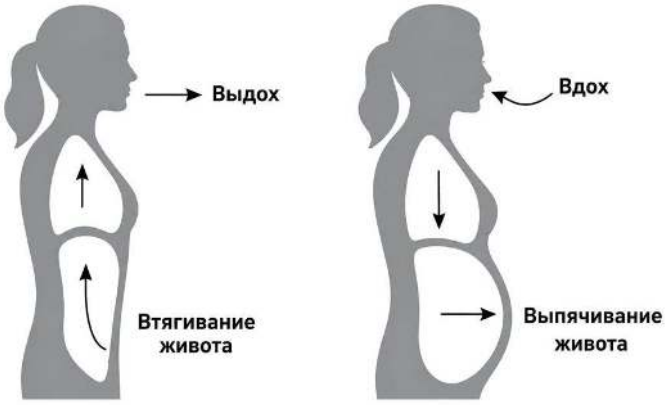
- ✔ ходьба
- ✔ плавание
- ✔ пилатес и спокойная йога
- ✔ лечебная физкультура

→ скручивания живота помогают желчеоттоку и моторике ЖКТ.

12. Диафрагмальное дыхание

Диафрагма — важная часть антирефлюксного барьера: её ножки охватывают пищевод и мешают избыточным забросам.

Регулярные упражнения на диафрагмальное дыхание помогают **улучшить координацию дыхания, уменьшить тревогу и стресс, поддержать работу нижнего пищеводного сфинктера и снизить частоту эпизодов рефлюкса.** Дополнительно они активируют блуждающий нерв.



Вдох — живот выпячивается, выдох — втягивается

Техника: глубокий вдох «в живот», затем выдох **в два раза медленнее вдоха.**
Можно выдыхать со звуком — так воздух выходит ещё медленнее.

13. Питание при ГЭРБ: главный принцип

Универсальной диеты при ГЭРБ не существует. Когда-то давались длинные списки запрещённых продуктов, но выяснилось: у разных людей изжогу вызывают разные продукты, а то, что провоцирует изжогу у одного, может её гасить у другого.

Главный принцип — индивидуальный подбор рациона.
Придерживайтесь вашего протокола питания на программе: в нём уже исключены триггеры изжоги и рефлюкса сообразно вашему типу пищеварения.

Ниже — контрольные точки, на которые стоит обращать внимание дополнительно: где бы вы ни ели и что бы вы ни ели.

14. Шесть правил питания при изжоге

1. Не переедать

Большой объём пищи растягивает стенки желудка и заставляет приоткрываться нижний пищеводный сфинктер.

- объём одного приёма пищи — **примерно до 300 мл**
- **есть спокойно**, не торопясь; на крупные приёмы пищи — **не менее 20 минут**
- заканчивать приём пищи **до появления чувства переполнения**

2. Есть медленно и тщательно пережёвывать

Быстрая еда = заглатывание воздуха = усиление рефлюкса и отрыжки.

При жевании выделяется слюна, а **слюна ощелачивает и нейтрализует кислоту в пищеводе** — это часть антирефлюксного барьера. Не есть на бегу и в машине: садиться за стол и уделять каждому приёму пищи достаточно времени.

3. Режим питания

- **3–5 полноценных приёмов пищи;**
- **без постоянных перекусов** — любой перекус может спровоцировать рефлюкс;
- последний приём пищи — **за 3–4 часа до сна.**

После еды желательно не ложиться и не наклоняться вперёд минимум 2 часа.

4. Тёплая еда (около 40–55 °C)

Очень горячая пища дополнительно раздражает воспалённую слизистую пищевода. Очень холодная — вызывает неприятные ощущения и может дать **спазм пищевода** и временно ухудшить моторику.

5. Достаточно жидкости

Воду лучше пить **небольшими порциями в течение дня**; предпочтительна тёплая вода **40–50 °C**. *При склонности к ночной изжоге не пить много перед сном.*

6. Продукты с пищевыми волокнами (клетчаткой)

Овощи, фрукты, зелень, ягоды, крупы, бобовые.

Пищевые волокна работают как натуральный прокинетик: ускоряют эвакуацию пищи из желудка, улучшают моторику кишечника, уменьшают вероятность запоров, помогают контролировать массу тела и способствуют снижению внутрибрюшного давления.

Достаточное количество клетчатки считается одним из наиболее полезных компонентов питания при ГЭРБ.

15. Триггеры рефлюкса: нужен дневник питания

Современные исследования показывают, что **триггеры рефлюкса индивидуальны.** Понаблюдайте, что вызывает изжогу именно у вас, — и затем исключите это.

Чаще всего это:

- **мята и ментол** — расслабляют нижний пищеводный сфинктер *(чаи, леденцы, листик мяты в напитке);*
- **алкоголь;**
- **крепкий кофе, крепкий чай, какао, шоколад;**
- **очень жирная пища** — тормозит моторику желудка;
- **острые блюда** с большим количеством специй;
- **газированные напитки, квас, пиво.**

Про кофе: если отказаться сложно, допустима **1 небольшая чашка после еды** — *никогда натощак. Кофе с молоком переносится мягче. Ориентируйтесь на индивидуальную переносимость.*

16. При воспалении пищевода — временно ограничить

Если диагностировано воспаление, эрозии или язвы, эти продукты плохо переносятся и могут усиливать боль. *Ограничение временное — до заживления слизистой.*

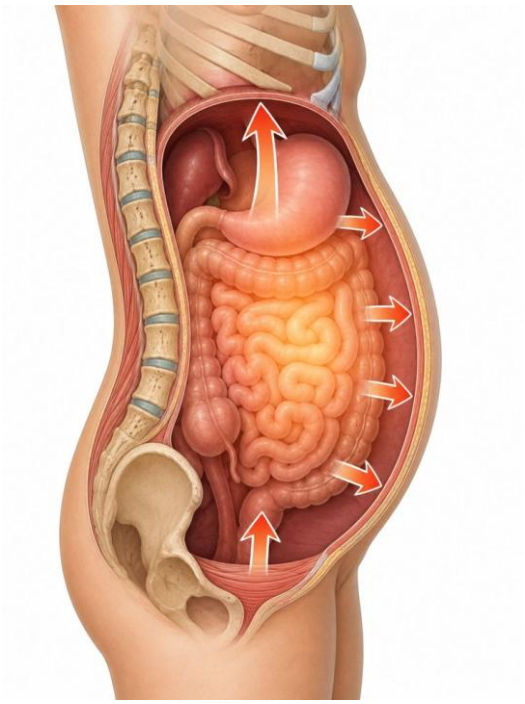
- **острые специи:** красный жгучий перец, чёрный перец, чеснок, хрен, горчица, имбирь, асафетида;
- **сырые чеснок и лук** *(в приготовленном виде действуют значительно мягче);*
- **продукты с выраженно кислым вкусом:** томаты, щавель, кислые ягоды, цитрусовые;
- **кетчупы и острые соусы;**
- **маринады и соленья;**
- **чипсы и снеки;**
- **фастфуд** и другая пища с усилителями вкуса и добавками.

17. Убираем высокое внутрибрюшное давление

ГЭРБ, как правило, вторична по отношению к другим проблемам пищеварительной системы — она их следствие. Убираем проблемы пищеварения — изжога и ГЭРБ проходят сами.

Самые частые причины высокого внутрибрюшного давления:

- **частое вздутие** — из-за дефицита ферментов, СИБР, СРК и других причин;
- **запоры** и частое натуживание;
- **переедание;**
- **лишний вес в области живота.**



Повышенное внутрибрюшное давление поддавливает желудок и диафрагму снизу вверх

Порядок работы: сначала разберитесь со вздутием — стратегии при разных его типах **принципиально разные** (ферментная недостаточность, СРК, СИБР). *Очень часто после этого изжогой отдельно заниматься уже не приходится.*

Рекомендации по вздутию и запорам — в соответствующих уроках курса. Начните с них.

18. Восстанавливаем пищеварение

Особенно важно при **вялом** типе пищеварения и смешанных вариантах с вялым. Без нормальной моторики от изжоги не избавиться.

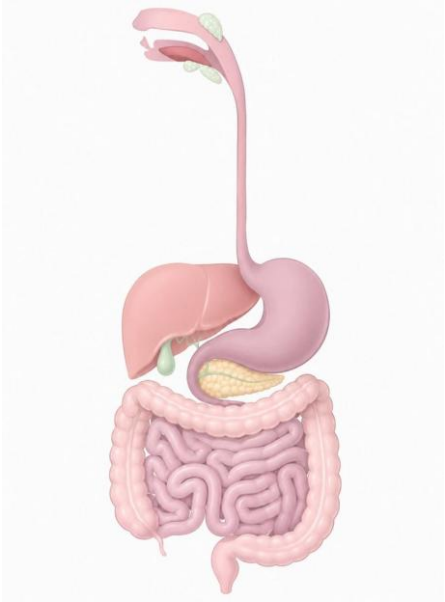
- Нормальная моторика и своевременное опорожнение желудка.
- Ферменты поджелудочной железы.
- Желчеотделение.
- Моторика желудка и кишечника.

Все необходимые рекомендации есть в ваших протоколах: в меню, кулинарных рецептах и уроках протокола.

«Просто попить что-то от изжоги» работает ровно до тех пор, пока вы это пьёте. Устраняем причины.

19. Восстанавливаем сфинктеры

Речь о **нижнем пищеводном сфинктере** и о сфинктере пилорического отдела — между желудком и двенадцатиперстной кишкой.



1. Сон и циркадные ритмы

- важно захватывать **пик мелатонина 22:00–2:00;**
- **стабильный отход ко сну** примерно в одно и то же время;
- **достаточная продолжительность сна** — недосып повышает уровень стресса и нарушает выработку нейромедиаторов.

2. Полноценное питание соединительной ткани и коррекция ДСТ

Соединительная ткань входит в состав сфинктеров, диафрагмы и связок. При **дисплазии соединительной ткани (ДСТ)** все антирефлюксные структуры работают слабее, а с возрастом ситуация постепенно ухудшается — процесс нужно тормозить.

- **достаточное количество белка** и его хорошее усвоение;
- **витамин С;**
- **медь;**
- **марганец;**
- **кремний;**
- **магний.**

Меню программы просчитано по питательным веществам. Не игнорируйте белок и занимайтесь улучшением его усвоения — как распределять по дню, какие порции и как готовить, есть в уроках каждого протокола.

3. Снижаем хронический стресс

Техники управления стрессом из ваших протоколов: **гимнастика, дыхательные практики, магний, ванночки для ног** и другие.

20. Восстанавливаем слизистую пищевода и убираем воспаление

Раздел для тех, у кого действительно повреждена и воспалена слизистая пищевода.

Используются растения и нутрицевтики с заживляющим и противовоспалительным действием: алтей, скользкий вяз, цинк-L-карнозин, глутамин, алоэ, витамины А и Е, облепиха, солодка DGL и другие.

Смотрите подробности в уроке «Заживляем слизистую» — у каждого решения есть свои нюансы использования.

Дополнительно: «противоязвенный фактор» — витамин U (S-метилметионин)

Витамин U способен:

- участвовать в процессах восстановления слизистой желудка и пищевода;
- защищать клетки слизистой от повреждения;
- уменьшать выраженность воспаления;
- способствовать более быстрому заживлению эрозий и язв;
- участвовать в синтезе фосфолипидов клеточных мембран.

Источники: белокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, спаржа, сельдерей. *Эти продукты желательно включать в рацион на регулярной основе.*



Рецепт: для ускорения заживления слизистой пить сок белокочанной капусты — по 1 ст. ложке 2–3 раза в день между приёмами пищи (по переносимости!).

Как сделать: мелко порубить кусочек капусты и помять его до появления сока — на день нужно всего 2–3 столовые ложки. *При правильном подходе слизистая заживает быстро: за 1–2 месяца возможны значимые улучшения.*

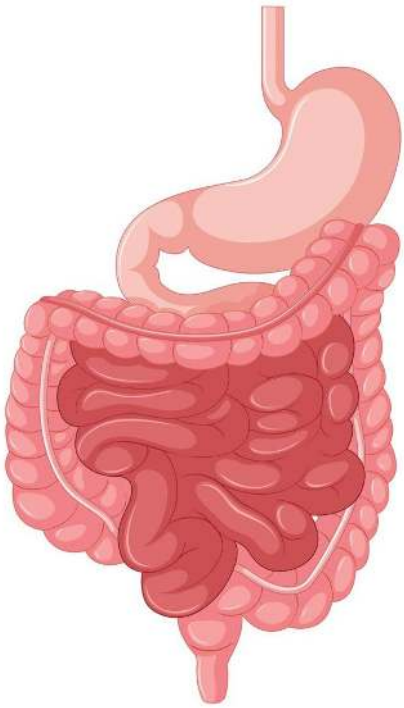
21. Улучшаем моторику желудка

Что ухудшает моторику

- постоянные перекусы, отсутствие «голодного окна»;
- переедание и большие объёмы пищи;
- избыток жиров за один приём пищи;

(порядка 50 г белка — это очень крупный кусок мяса);

- длительный стресс;
- нарушение сна, недосып;
- гиподинамия;
- снижение тонуса блуждающего нерва;
- дефицит ацетилхолина;
- высокий дофамин;
- воспаление слизистой желудка.



Интервалы между приёмами пищи: 3,5–5 часов.

Движение

10–20 минут спокойной ходьбы после еды значительно ускоряют эвакуацию содержимого желудка.

Повышение активности блуждающего нерва

- диафрагмальное дыхание, медленный длинный выдох;
- пение;
- смех;
- полоскание горла;
- умывание холодной водой.

Работа со стрессом

Высокий симпатический тонус буквально «выключает» пищеварение — во время стресса организм считает, что нужно драться или убегать, а не переваривать еду.

Во время хронического стресса:

- снижается выделение ацетилхолина;
- повышается уровень дофамина;
- уменьшается сила сокращений желудка;
- нарушается координация антрального отдела и привратника.

22. Пищевые прокинетики

Горечи: руккола, садовая зелень, цикорий, эндивий, радиккьо, листья одуванчика, артишок.

Лимон — *только при отсутствии активной изжоги и эрозий.*

Ферментированные продукты — органические кислоты стимулируют желудочную секрецию.

Белок: яйца, рыба, птица, морепродукты — регулярно и умеренными порциями.

Клетчатка — овощи, фрукты, зелень, ягоды, крупы, бобовые.

Специи-прокинетики

Работают за счёт повышения холинергической передачи: **имбирь, чёрный перец, кориандр, фенхель, кардамон, кумин (зира), розмарин, куркума, чёрный тмин.**



Используйте их сообразно вашему протоколу: для одних типов пищеварения список специй шире, для других — ограничен небольшими количествами.

Растительные прокинетики (по назначению врача): Иберогаст — по 30 капель 2–3 раза в день, курсами по 2–3 недели.

23. Итоговый алгоритм: если есть изжога

Изжога чаще 2 раз в неделю, продолжительная, беспокоит несколько недель подряд.

1. Альгинатный тест (по желанию). Принять Гевискон на фоне изжоги: прошла за 3–6 минут — вероятна ГЭРБ. *Не прошла — тоже нужно обследование, но искать будем другое.*

2. Диагностика с гастроэнтерологом: список жалоб и симптомов, опрос, ФГДС, по необходимости — 24-часовая pH-импедансометрия.

3. Применяем базовые меры в питании и образе жизни — всё, что разобрано в этом уроке.

4. Оцениваем свой тип пищеварения и жалобы и расставляем приоритеты коррекции.

24. Тактика по типам пищеварения

Вялый тип пищеварения	• **Устраняем вздутие** из-за недостатка ферментов поджелудочной и плохого желчеоттока. • Улучшаем **моторику желудка.** • Убираем то, **что тяжело переваривается** — тяжёлые сочетания, избыток жиров и т. д.
Чувствительный тип пищеварения	• **Устраняем вздутие из-за СРК** — меры из соответствующего урока. • Работаем **со смыканием сфинктеров желудка.** • **Снижаем чувствительность пищевода** — стресс, сон, белок, жиры и другие защитные факторы слизистой.
Воспалённый тип пищеварения	• **Устраняем вздутие из-за СИБР** и воспаления в кишечнике. • **Заживляем слизистую пищевода** и снижаем воспаление. • Восстанавливаем **смыкание сфинктеров желудка.**

Смешанный тип пищеварения	• Меры при **вялом** типе пищеварения. • Меры при **воспалённом** типе пищеварения. • *Есть повреждение слизистой — приоритет мерам воспалённого типа; слизистая цела — начинаем с мер вялого типа.*

25. Главный вывод урока

Изжога — это не диагноз, а симптом. ГЭРБ — не самая сложная болезнь. Даже если есть воспаление и повреждение пищевода и картина выглядит не очень хорошо, грамотная работа с питанием и образом жизни значимо улучшает ситуацию **в любом возрасте и достаточно быстро** — в течение одного-двух месяцев. Сам симптом изжоги может уйти значительно раньше, сразу после устранения основной причины.

Считается, что ГЭРБ можно только вывести в ремиссию. Практика показывает: диагноз снимается по результатам обследования, если работать с причинами, а не только гасить симптом.

26. Вопросы для самопроверки

Ответьте своими словами, не подглядывая в конспект. Если ответ не складывается — вернитесь к указанному разделу.

Препараты

1. Что делают ИПП и почему они не снимают уже начавшийся приступ изжоги? *(раздел 2)*

2. Назовите три группы рисков длительного приёма ИПП. *(раздел 3)*

3. Что такое кислотный рикошет и почему из-за него трудно отменить препарат? *(раздел 4)*

4. Чем антациды отличаются от альгинатов по механизму действия? *(разделы 5–6)*

5. Зачем при отмене ИПП назначают прокинетики? *(раздел 7)*

6. Объясните, почему сода в итоге усиливает рефлюкс, а не убирает его. *(раздел 8)*

Образ жизни и питание

7. На сколько процентов нужно снизить вес, чтобы это дало значимый эффект? *(раздел 9)*

8. Почему рекомендуют спать на левом боку и с приподнятым изголовьем? *(раздел 10)*

9. Какие виды активности ограничивают при ГЭРБ и почему? *(раздел 11)*

10. Как диафрагмальное дыхание влияет на антирефлюксный барьер? *(раздел 12)*

11. Почему универсальной диеты при ГЭРБ не существует? *(раздел 13)*

12. Перечислите шесть правил питания и объясните смысл каждого. *(раздел 14)*

13. Почему мята попала в список триггеров? *(раздел 15)*

Причины и практика

14. Почему работу начинают со вздутия, а не с изжоги? *(раздел 17)*

15. Как связаны ДСТ, белок и смыкание сфинктера? *(раздел 19)*

16. Что такое витамин U и где он содержится? *(раздел 20)*

17. Назовите пять факторов, ухудшающих моторику желудка, и три способа её улучшить. *(раздел 21)*

18. Какие меры в приоритете при вашем типе пищеварения? *(раздел 24)*

27. Практическое задание

1. Составьте свой базовый чек-лист из раздела 9 — вес, курение, алкоголь, одежда, лекарства. Отметьте пункты, над которыми вам есть что поменять.

2. Наладьте сон на две недели по правилам раздела 10: отбой до 23:00, ужин за 3–4 часа, левый бок, приподнятое изголовье.

3. Ведите дневник питания две недели и найдите свои личные триггеры — сверьтесь со списком из раздела 15.

4. Пройдите по шести правилам питания (раздел 14) и выберите два, которые нарушаете чаще всего. Начните с них.

5. Добавьте диафрагмальное дыхание — 5 минут в день и 10–20 минут спокойной ходьбы после крупных приёмов пищи.

6. Если вы принимаете ИПП — обсудите с врачом схему постепенной отмены. *Не отменяйте резко и самостоятельно.*

7. Определите ведущий механизм по разделу 24 и откройте нужные уроки курса: по вздутию, по запорам, «Заживляем слизистую».

Убираем проблемы пищеварительной системы — изжога и ГЭРБ проходят сами.

Дневник питания и симптомов

Заполняйте в течение двух недель. Отдельно отмечайте ночные эпизоды.

Дата и время	Что ел(а) / пил(а)	Симптом и сила 0–10	Положение тела, нагрузка
